

Tier 3 — วิเคราะห์สาเหตุ (ของจริง ที่ถูกอ้างเกินตัว)

ชั้นนี้กลับด้าน: ปรากฏการณ์ มีจริง วิทยาศาสตร์กระแสหลักยอมรับ — เราไม่ debunk. สิ่งที่ดีคือแค่ “การตีความเกิน” ที่กระโดดจากกลไกสมองธรรมดาไปเป็นเรื่องเหนือกาย. ตัวขับเคลื่อนหลักมักเป็น สมอสร้างเอง (กลไกจริง) + ตีความเกิน (จุดผิด). และมีหนึ่งเคส (hard problem) ที่ เปิดค้างจริง = [OPEN]

น้ำหนัก: **dominant** = ตัวขับเคลื่อนหลัก · **secondary** · minor

ลายเซ็นร่วมของ 6 เคสแรก: ปรากฏการณ์จริง (Type-B, กลไกสมองที่รู้จัก) + Layer-1 ล้วน — ไม่มีเคสไหนส่ง Layer-2 (ความรู้/ภาษา/fact เดาไม่ได้). เคสที่ 7 (hard problem) ต่างออกไป: เป็นคำถามที่ ยังเปิดจริง — ยอมรับตรงๆ ว่ายังไม่มีคำตอบ และมันก็ ไม่ใช่ใบอนุญาตให้เรื่องเหนือกายใดๆ

TIER 3 — ของจริง แต่ถูกดึงไปอ้างว่า “จิตพิเศษ/เหนือกาย”



อ้าง: ยาหลอกพิสูจน์ว่า “จิตรักษาภายใต้โดยตรง / คิดให้หายป่วยอะไรก็ได้” = จิตเหนือสสาร

สูตรสาเหตุ (CAUSE RECIPE) · ของจริง + จุดที่ดีความเกิน

dominant

สมองสร้างเอง (กลไกจริง) ตัวจริงและเป็นเคมีล้วน. ความคาดหวัง/การวางเงื่อนไข → สมองปล่อยสารโอปิออยด์ของตัวเอง (Levine 1978: naloxone ปิดฤทธิ์ยาหลอกได้), ปล่อยโดพามีนในผู้ป่วยพาร์กินสัน (de la Fuente-Fernández 2001, Science), ผั่งร้าย (nocebo) ผ่าน CCK (Benedetti 2006, ปิดด้วย proglumide). ทุกขั้นตอน “วัดได้-บล็อกได้”

dominant

ดีความเกิน จุดผิด. เอา “สัญญาณสมอง→กาย ที่จริงแต่จำกัดขอบเขต” ไปพองเป็น “จิตควบคุมสสารโดยตรง รักษาได้ทุกอย่าง”

secondary

ปัญหาการทดลอง สิ่งที่เราเรียก “พลังยาหลอก” ส่วนใหญ่จริงๆ คือ regression to the mean + หายเอง (natural history) — เห็นชัดเมื่อเทียบกับกลุ่ม “ไม่รักษาเลย” (Hróbjartsson & Gøtzsche, NEJM 2001)

secondary

บังเอิญ+จำแต่ที่ตรง คนเข้าโครงการตอนอาการพีค (แล้วก็ดีขึ้นเองตามธรรมชาติ), รายงานเข้าข้างตัวเอง — พองผลยาหลอกที่มองเห็น

minor

ความจำแต่งเรื่อง จำว่า “เมื่อก่อนแยกว่านี้มาก” เกินจริง ทำให้รู้สึกว่ายดีขึ้นเยอะ

minor

เห็น/ได้ยินผิด ความคาดหวังเปลี่ยน “การรับรู้” ความเจ็บของสิ่งเร้าเดิม (ปวดเท่าเดิมแต่ให้คะแนนน้อยลง)

กฎ 2 ชั้น · แพทเทิร์น VS ความรู้

Layer 1 ล้วน. ขยับความเจ็บ/อารมณ์/โดพามีนผ่านเคมีที่รู้จัก — จริงแต่มีขอบเขต. Layer 2 (คิดให้ก่อนมะเร็งหาย / งอกแขนใหม่ / ล้างเชื้อ) = ไม่เคยส่ง. Hróbjartsson & Gøtzsche 2001: กับ endpoint ที่เป็น วัตถุวิสัย/binary ยาหลอก $\approx$ ไม่รักษาเลย

เทสต์ที่แยกจริง/ธรรมดา: วัด endpoint เชิงโครงสร้างจริง (ขนาดก้อน / การสแกนแผล / การล้างเชื้อ / อัตราตาย) แบบ blinded เทียบยาหลอก vs ยาจริง vs ไม่รักษา. ทำนาย: ยาหลอกขยับ “อาการที่รายงานเอง + ที่ผ่านเคมีประสาท” (SMD ~ -0.30) แต่ไม่ขยับ “โรคเชิงโครงสร้าง” (SMD ~ -0.10 , ไม่นัย). ประวัติจริงตรงกับสายนี้เป๊ะ

confidence: high · Levine, Gordon & Fields 1978, Lancet 2:654 (naloxone reverses placebo analgesia); Hróbjartsson & Gøtzsche 2001, NEJM 344:1594 (“Is the placebo powerless?”); de la Fuente-Fernández et al. 2001, Science 293:1164 (striatal dopamine); Benedetti et al. 2006, J Neurosci 26:12014 (nocebo/CCK); Kaptchuk et al. 2010, PLoS ONE (open-label). ประเภท: Type-B

อ้าง: การสะกดจิตปลดพลังลับ / เปิดความจำที่ถูกกดไว้ได้อย่างแม่นยำ / พาย้อนไปชาติก่อนได้จริง

สูตรสาเหตุ (CAUSE RECIPE) · ของจริง + จุดที่ดีความเกิน

dominant

สมองสร้างเอง (กลไกจริง) ตัวจริง — สภาวะสมาธิ + การชี้นำ + ความคาดหวัง มี top-down control จริง. Raz 2005 (PNAS): คำสั่งหลังสะกดจิตลด Stroop interference + ลด ACC; ระบุปวดได้จริง (meta $g=0.44$, $d=0.67$); ระดับ “ถูกสะกดง่าย” เป็น trait นิ่ง 25 ปี ($r=.71$, Piccione/Hilgard 1989). ไม่ใช้การหลับ ไม่ใช้การเสียเจตจำนง

dominant

ความจำแต่งเรื่อง จุดผิดฝั่งความจำ. สะกดจิตทำให้ “มั่นใจขึ้น + จำได้เยอะ/ชัดขึ้น แต่ไม่ได้แม่นยำขึ้น” และเพิ่ม false memory (Loftus). ระลึกชาติ = cryptomnesia ที่เอาชีวประวัติ/สื่อ/คำใบ้ของผู้สะกดมาปั้น (Spanos 1991: เนื้อหาเปลี่ยนตามที่ถูกสะกด cue และ ผิดยุคประวัติศาสตร์). ทางกฎหมายเลยห้ามใช้ forensic hypnosis

dominant

ดีความเกิน จุดผิด. เปลี่ยนป้ายจาก “สภาวะสมาธิ/ชี้นำที่จริง” เป็น “วงค์ลึกลับ / ประตูลึกลับ / ความจำชาติก่อนจริง”

secondary

ปัญหาการทดลอง ผู้สะกดไม่ปิดตา, คำถามนำ, demand characteristics ปั่นเนื้อหา — Spanos แสดงว่า framing ของผู้สะกด “สร้าง” เนื้อหาเอง

secondary

ข้อมูลรู้ทางปกติ คำถามนำ + cue ก่อนสะกด บ่อนเนื้อหาที่จะ “จำได้” ที่หลัง

minor

คนแก่ง มีบ้างในนักโพรโมต แต่ส่วนใหญ่จริงจัง — ไม่ใช่ตัวขับ

กฎ 2 ชั้น · แพทเทิร์น VS ความรู้

Layer 1 ล้วน (สมาธิ/ระบุปวด/absorption จริง). Layer 2 (ความจำที่เข้ารหัสไม่ได้ / ภาษาที่ไม่เคยเรียน / fact ที่เดาไม่ได้) = 0 ภายใต้การตรวจสอบ — ระลึกชาติกลายเป็น cryptomnesia ท้นที่ที่เทียบกับ record จริง

เทสต์ที่แยกจริง/ธรรมดา: เอา “ความจำที่กุมมา” ให้คะแนนแบบ blind เทียบ record อิสระ + มีกลุ่มควบคุม false-memory + วัดความมั่นใจ. ทำนาย (Layer-1): ความมั่นใจขึ้นแต่ความแม่นยำไม่ขึ้น, เนื้อหาสวไปเจอแหล่งปกติได้, และเปลี่ยนตาม framing ของผู้สะกด (ตรงกับ Spanos 1991)

confidence: high · Raz, Fan & Posner 2005, PNAS 102:9978; Oakley & Halligan 2013, Nat Rev Neurosci 14:565; Spanos et al. 1991, JPSP 61(2):308 (past-life = สร้างขึ้น); Piccione, Hilgard & Zimbardo 1989, JPSP 56:289 (trait $r=.71$); Loftus & Pickrell 1995 (false memory). ประเภท: Type-B

ESTABLISHED

T3



Meditation / mystical states — สมาธิ / ประสบการณ์เอกภาพ

อ้างอิง: สมาธิ/ประสบการณ์เอกภาพ = จิตเชื่อมกับ “จิตจักรวาล” / จิตไปไกลเกินสมอง / พิสูจน์ว่าสำนึกเหนือกาย

สูตรสาเหตุ (CAUSE RECIPE) · ของจริง + จุดที่ดีความเกิน

dominant

สมองสร้างเอง (กลไกจริง)

ตัวจริง — DMN (default mode network) ลดการทำงานในผู้ฝึกนาน (Brewer 2011, PNAS), gamma synchrony ในพระทิเบต (Lutz 2004), ego-dissolution = DMN สลายตัว (Carhart-Harris entropic brain — ยาเห็ด psilocybin ก็ทำได้เหมือนกัน). “รู้สึกไร้ขอบเขต/รวมเป็นหนึ่ง” คือสิ่งที่ self-model ของสมองทำตอนมันแตกออก

dominant

ดีความเกิน

จุดผิด + กับดัก noetic certainty: อาการเด่นคือ “มั่นใจสุดขีดว่าจริงกว่าจริง”. แต่ **ความรู้สึกมั่นใจที่สมองปั้นขึ้น $\neq$ เครื่องวัดความจริง** — ความแรงของความเชื่อไม่ได้บอกว่าการดีความ “จักรวาล” ที่แปะที่หลังถูก

secondary

ปัญหาการทดลอง

Goyal 2014 (JAMA, 47 trials): พอใช้ active control ผลหด — ไม่ดีกว่ายา/ออกกำลัง (SMD ~ 0.3); ขาด active control พองผลในงานยุคแรก

secondary

บังเอิญ+จำแต่ที่ตรง

fMRI กลุ่มเล็ก effect พอง, กลุ่มผู้ฝึก elite เลือกเอง (Lutz $n=8$), publication bias

minor

ความจำแต่งเรื่อง

เล่าประสบการณ์ที่พูดไม่ถูก ให้กลายเป็น “จักรวาล” ที่หลัง (การดีความแปะตอน recall)

กฏ 2 ชั้น · แพทเทิร์น VS ความรู้

Layer 1 อิ่มมาก (สมาธิ / self สลาย / ปิติ / เอกภาพ / ความมั่นใจล้น) — จริงและวัดได้. แต่ Layer 2 (fact ที่ตรวจสอบได้ เดาไม่ได้ จาก “จักรวาล”) = 0. ไม่มีผู้ฝึกคนไหนกลับมาพร้อมข้อมูลนอกหัวตัวเองสักครั้ง

เทสต์ที่แยกจริง/ธรรมดา: สภาวะ mystical เคยส่ง “ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ เดาไม่ได้ นอกความรู้ผู้ฝึก” เกินสุ่มไหม (เป้าฝึก/fact ลับ)? — และถ้าพลิกสมอง (ยาเห็ด / ketanserin บล็อกตัวรับ / ฝึก) ก็พลิกประสบการณ์ = สมอง “สร้าง” ไม่ใช่ “รับ”. ทำนาย: ได้ transformation ล้าลึกแต่ข้อมูลนอก = 0

confidence: high · Goyal et al. 2014, JAMA Intern Med 174:357 (SMD ~ 0.3 , ไม่ดีกว่า active control); Brewer et al. 2011, PNAS 108:20254 (DMN); Lutz et al. 2004, PNAS 101:16369 (gamma); Carhart-Harris et al. 2014, Front Hum Neurosci 8:20 (entropic brain); Barrett/Johnson/Griffiths 2015 (MEQ30 noetic quality). ประเภท: Type-B



อ้าง: savant “ดาวนโหลด” อัจฉริยะ / เข้าถึงจิตสากล — คนพิการจะรู้วันปฏิทินทันทีได้อย่างไร ถ้าไม่ได้มาจากนอกสมอง?

สูตรสาเหตุ (CAUSE RECIPE) · ของจริง + จุดที่ดีความเกิน

dominant

สมองสร้างเอง (กลไกจริง) ตัวจริง — สมองซีกซ้ายเสีย/ถูกกด → ซีกขวา (เน้นรายละเอียด) ทำงานแทน (paradoxical facilitation), weak central coherence, เข้าถึง “ข้อมูลดิบชั้นล่าง” ที่ปกติถูกกดไว้ (Snyder 2009). หลักฐานชี้ขาด: TMS กดสมองกลีบขมับซ้ายปลุกทักษะแบบ savant ในคนปกติได้ **10/12** (Snyder 2006) — ซ่อง “ดาวนโหลด” ไม่น่าเปิดด้วยขวดลวดแม่เหล็ก

dominant

ดีความเกิน จุดผิด. เพราะทักษะ “ไม่ได้เรียนมา” เลยสรุปว่า “ต้องมาจากนอกสมอง” — สับสนระหว่าง “ไม่ถูกสอน” กับ “คำนวณไม่ได้”

minor

บังเอิญ+จำแต่ที่ตรง เล่าแต่เคสน่าทึ่ง (Peek/Tammet) เคสธรรมดา (ผิวดลาดเยาะ) ถูกมองข้าม → ภาพลวงว่า “เป็นไปไม่ได้”

กฏ 2 ชั้น · แพทเทิร์น VS ความรู้

เคสที่สะอาดที่สุดของกฏ 2 ชั้น. ทุกทักษะคือ Layer-1 แพทเทิร์น/การคำนวณที่สมองสร้างเองได้ — ปฏิทินมีคาบ 400 ปี derive ได้, นับจำนวนเฉพาะ, โครงสร้างดนตรี, ความจำดิบ. **ไม่เคยส่ง Layer-2:** ภาษาที่ไม่เคยเรียน / fact ที่ไม่เคยเจอ / ทฤษฎีบทใหม่. Kim Peek จำ 12,000 เล่มที่ “อ่านมาก่อน” ทุกอย่าง; นักคิดปฏิทินตอบทันทีแต่ “อธิบายกฎไม่ได้” = pattern lookup อัตโนมัตินิไม่ใช่อracle

เทสต์ที่แยกจริง/ธรรมดา: หา savant สักคนที่ส่ง Layer-2 จริง — ภาษาที่ไม่เคยเรียน / fact ที่ไม่เคยรับผ่านประสาทสัมผัสใดๆ / ทฤษฎีบทใหม่ที่ derive จากสิ่งที่เข้าถึงไม่ได้. ไม่มีเลยสักคน. ทุกทักษะเป็นได้แค่ (ก) ความจำของสิ่งที่เจอมาก่อน หรือ (ข) การคำนวณบนโดเมนที่มีแบบแผน — และบางส่วนปลุกได้ด้วย TMS ในคนปกติ

confidence: high · Snyder 2009, *Phil Trans R Soc B* 364:1399 (privileged access); Snyder et al. 2006 (TMS ปลุก numerosity 10/12); Treffert 2009, *Phil Trans R Soc B* 364:1351; Kim Peek (agenesis of corpus callosum). ประเภท: Type-B



อ้าง: (ก) จิตสำนึกคือ “ส่วนพิเศษเหนือกาย” ที่จำเป็นต่อการเห็น; หรือ (ข) blindsight = จิตสำนึกที่ซ่อนอยู่ / ตาพิพม์

สูตรสาเหตุ (CAUSE RECIPE) · ของจริง + จุดที่ดีความเกิน

dominant

สมองสร้างเอง (กลไกจริง) ตัวจริง — V1 (คอร์เทกซ์การเห็น) เสีย ตามอดแบบ “รู้ตัวว่าไม่เห็น” แต่ทางลัด retina→superior colliculus→pulvinar→extrastriate ยังทำงาน. ผู้ป่วย DB แยกรูปได้ 86%/73% ทั้งที่รายงานว่ารู้สึกเห็นแค่ ~1 ใน 100 ครั้ง (Weiskrantz 1974). ปิดทางลัด (SC/pulvinar/LGN) ความสามารถหาย (Schmid 2010; Kinoshita 2019) = ภาพภาพล้น

dominant

ดีความเกิน จุดผิด 2 ทาง. (ก) จริงๆ blindsight ชี้ **ตรงข้าม** — เห็นได้โดยไม่ต้องมีสำนึก = สำนึกไม่ใช่ “ส่วนพิเศษ” ที่ทำให้เห็น; (ข) ไม่ใช่ตาพิพม์ — เป็นแค่การเห็นภาพที่เสื่อมผ่านสมองส่วนล่าง

minor

ปัญหาการทดลอง เคยมีข้อโต้แย้ง light scatter / response-criterion (Campion 1983) — ถูกคุมแล้ว (ใช้เคส V1 หายทั้งซีก, แยก d' ออกจาก criterion) ปรากฏการณ์รูดการตรวจสอบ

กฏ 2 ชั้น · แพทเทิร์น VS ความรู้

Layer-1 (ตำแหน่ง/การเคลื่อนไหว/รูปหยาบ ที่ถ่ายทอดอยู่แล้ว) — ไม่มี Layer-2. ความสำคัญต่อการรอบคิด: ชี้ว่า **“จิตส่วนใหญ่คือเครื่องจักรกายภาพที่ไร้สำนึก”** (masked priming ก็เช่นกัน) — สำนึกเป็นแบบ graded/แยกส่วนได้ ไม่ใช่สวิตช์เหนือกายแบบ all-or-nothing

เทสต์ที่แยกจริง/ธรรมดา: ความสามารถวิ่งตามทางประสาทกายภาพ — ปิดสมองส่วนล่าง (SC/pulvinar/LGN) แล้วมันหาย; และเนื้อหาไม่เคยเกินที่ถ่ายทอด. “ตาพิพม์” จะส่งข้อมูลที่ไม่ได้ถูกฉายให้ตาเห็น — ซึ่งไม่เคยเกิด

confidence: high · Weiskrantz et al. 1974, Brain (บัญญัติคำ “blindsight”, ผู้ป่วย DB); Schmid et al. 2010, Nature (ต้องพึ่ง LGN); Kinoshita et al. 2019, Nat Commun (SC/pulvinar); Campion, Latt & Smith 1983, BBS (ข้อโต้แย้ง scatter/criterion ที่ถูกคุมภายหลัง). ประเภท: Type-B



อ้างอิง: ผ่าสมองแยกซีก = พิสูจน์เรื่อง “วิญญาณเอกภาพ” (ทั้งฝ่ายหนุ่นและฝ่ายค้าน dualism ต่างหยิบไปอ้าง)

สูตรสาเหตุ (CAUSE RECIPE) · ของจริง + จุดที่ดีความเกิน

dominant

สมองสร้างเอง (กลไกจริง) ตัวจริง — ตัด corpus callosum (Sperry ได้ Nobel 1981). ซีกขวา เห็น/ทำสิ่งที่ซีกซ้าย (ซีกที่พูด) รายงานไม่ได้; ให้ข้อมูลขัดกันได้ 2 ซีก; “ลามซีกซ้าย” (Gazzaniga) แต่งเหตุผลเนียนๆ ให้พฤติกรรมที่ตัวเองไม่รู้ ต้นเหตุ

dominant

ดีความเกิน จุดผิด 2 ทาง — dualist กับ physicalist ต่างอ้าง. ข้อเท็จจริงที่ “รอยตัดกายภาพแบ่งความสามารถของจิต” **ตรงกับ** ข้ออ้าง “วิญญาณเป็นหนึ่งเดียวแบ่งไม่ได้” (ถ้าจิตสื่อสารเหนือกายที่แบ่งไม่ได้ ตัดเส้นใยไม่ควรแบ่งการรับรู้/ความรู้/การกระทำได้)

secondary

ปัญหาการทดลอง cross-cueing artifacts, ผู้ป่วยตัดสมบูรณ์มีน้อยมาก, ผลขึ้นกับ modality/วิธีตอบ — Pinto 2017 (Brain): “แยกการรับรู้ แต่สำนึกไม่แยก” ทำทนายภาพ 2-agents (แต่อยู่บนผู้ป่วย 2 คน และยังเถียงกันอยู่)

กฏ 2 ชั้น · แพทเทิร์น VS ความรู้

ไม่ใช่ข้ออ้างส่งข้อมูล — Layer-1 (ประมวลผล/ส่งข้ามซีก) กายภาพล้วน, ไม่มี Layer-2. **หมายเหตุสำคัญ:** ตัดในฐานะ “หลักฐานเชิงอภิปราย” (ทั้ง 2 ทาง) — แต่มัน **จำกัดกรอบทฤษฎีเรื่องตัวตน:** ตรงกับวิญญาณที่แบ่งไม่ได้. ส่วนคำถาม “1 สาย หรือ 2 สาย” ยังเป็นการถกเถียงที่เปิดอยู่จริง (Pinto vs นักปรัชญาสาย phenomenal-unity)

เทสต์ที่แยกจริง/ธรรมดา: ความสามารถ/การแยกวิ่งตามกายวิภาคของ callosum (ตัด = แยก, ทางลัด subcortical = รั่วบางส่วน). ไม่มีการส่งข้อมูลเหนือกายเข้ามาเกี่ยวเลย — คำถามที่เหลือเป็นเรื่อง “จำนวนสายสำนึก” ล้วนๆ ซึ่งเป็นการถกเถียงเชิงประจักษ์/ปรัชญาที่ยังไม่ปิด

confidence: high · Sperry — Nobel 1981; Gazzaniga 2017, Brain 140(7):2051 (“interpreter”, 50-year review); Pinto et al. 2017, Brain 140(5):1231 (“divided perception but undivided consciousness”); critics: Neuropsychologia 2021 / Philosophical Studies 2025 (layered-unity models). ประเภท: Type-B

OPEN

T3

★ The Hard Problem of Consciousness — ทำไมถึง “มีความรู้สึก”

คำถาม: ทำไมการประมวลผลทางกายภาพถึงมี “ประสบการณ์/ความรู้สึก” (qualia) มาด้วย? ทำไมมันไม่ทำงานไปเฉยๆ “ในความมืด”? — นี่คือเคสเดียวในทั้งชุดที่ผม ยอมรับว่าเปิดค้างจริง ไม่ debunk ไม่แก้เกลี้ยง

สถานะจริง · ยังไม่มีข้อสรุป (ตัวแทนจุดยืนอย่างเป็นทางการ)

ตั้งปัญหา

Chalmers 1995 แยก “easy problems” (ฟังก์ชัน: จำแนก, รายงาน, ตั้งใจ — แก้ได้ด้วยวิสิกลไก) ออกจาก “hard problem” (ทำไมการทำงานนั้นถึง ‘ถูกรู้สึก’) ที่ดูจะดื้อต่อวิสิกลไก

ฐานราก

Nagel 1974 (“เป็นค่างควารู้สึกยังงี้” — มุมมองบุคคลที่หนึ่งจับด้วยภาษาวัตถุวิสัยไม่ได้); Levine 1983 (“explanatory gap”); Jackson (ห้องของ Mary — แต่ Jackson เองภายหลังกลับมาเป็น physicalist)

จุดยืนที่เกี่ยวข้องกัน

illusionism (Dennett/Frankish — qualia เป็นภาพลวง ไม่มี hard problem จริง) · property dualism (Chalmers — จริงและลดทอนไม่ได้ อาจเป็นพื้นฐานจักรวาล) · panpsychism (Goff / IIT ของ Tononi — สำนึกมีอยู่ทุกที่) · ทฤษฎีที่แก้แค่ easy problem (GNWT ของ Dehaene, higher-order)

หลักฐานล่าสุด

Cogitate 2023/2025 (Nature) ทดสอบ IIT vs GNWT แบบ adversarial, 256 คน, fMRI/MEG/iEEG → ไม่มีฝ่ายไหนชนะสะอาด, ก้าวหน้าเรื่อง “correlates” แต่ hard problem ไม่ถูกแตะ. จดหมาย “IIT = pseudoscience” 124 คน (ก.ย. 2023) + คนค้าน (Seth/Goff) = วงการยังไม่นิ่ง

ทำไมเปิดจริง

ไม่ใช่ช่องว่างชั่วคราว: แม้อธิบาย easy problem ครบทุกอย่าง คำถาม “ทำไมถึงรู้สึก” ก็ยังค้าง เพราะการอธิบายเชิงฟังก์ชันบอก “ระบบทำอะไร” ไม่ใช่ “ทำไมทำแล้วมีประสบการณ์” — เป็นความเปิดเชิงโครงสร้าง

firewall สำคัญ

hard problem = คำถามเรื่อง “ธรรมชาติของประสบการณ์” ไม่ใช่ใบอนุญาตให้ telepathy / วิญญาณ / ชามชาติ. “ยังไม่รู้ว่าทำไมประมวลผลแล้วรู้สึก” ≠ “จิตแยกจากสมองได้” — เหมือนว่าเท่ากันคือ category error ที่ต้องกันไว้

กฏ 2 ชั้น · ORTHOGONAL (อยู่นอกแกนส่งข้อมูล)

อยู่นอกแกน “ส่งข้อมูล” เลย (orthogonal). ไม่ใช่ข้ออ้าง Layer-1 (ไม่มีอะไรเคลื่อนที่) และไม่ให้ Layer-2 (ไม่มีการส่งเหนื่อกาย). มันคือคำถามว่า “ทำไม Layer-1 ถึงมีประสบการณ์มาด้วย” — ถือ physicalism เข้มเรื่องการไหลของข้อมูลได้พร้อมกับยังเจอ hard problem อยู่

ท่าที่ที่ถูก: ไม่มีการทดลองไหนปิดได้ในตอนนี้ (Cogitate ก็ไม่แตะ). ท่าที่ที่ถูกของกรอบที่มีวินัย = ยอมรับความเปิดตรงๆ อย่าเอาอุปสรรคที่ตัวเองชอบไปเติมกล่องเปล่า แสดงจุดยืนคู่แข่งอย่างเป็นทางการ ไม่ลักไก่คำตอบ (physicalist / dualist / paranormal ก็ห้ามลักไก่เหมือนกัน)

confidence: n/a (frontier) · Chalmers 1995, *J Consciousness Studies* 2(3):200; Nagel 1974, *Phil Review* 83:435; Levine 1983 (explanatory gap); Jackson 1982 (*Mary's room*, ภายหลัง recant); Cogitate Consortium 2025, *Nature* 642:133 (IIT vs GNWT, ไม่ชี้ขาด). สอดคล้องกับคีย์สโตนที่ CoE เปิดค้างไว้อย่างซื่อสัตย์ (§6.7)

สร้างจาก 5-agent deep-research pass (placebo · hypnosis · meditation · savant+blindsight · split-brain+hard problem) · companion กับ Tier 0+1 · Tier 2 · Deep Dossier · Evidence Map · เก็บนอกเอกสาร CoE (§6.6) · งานวิจัยทั่วไปไม่มีข้อมูลส่วนตัว